

# 患者与家庭照护者需求调研报告

家长访谈示例与队员访谈模板

项目用途 AI 医疗 workflow 黑客松前期用户发现

整理日期 2026 年 10 月 2 日 中国时间

团队产品负责人 Joanna

访谈素材 父亲与母亲的口述回顾

## 调研目的与主要发现

本报告帮助团队从真实就医经历中识别可验证的工作流问题，并提供一致的访谈记录方式。两位受访者来自同一家庭：父亲主要承担预约与陪诊，母亲主要从患者角度描述医嘱理解、资料交接和信任问题。

初步发现集中在三个环节：就诊前难以辨别服务入口与预约规则；就诊后缺少充分解释和执行支持；跨次就诊时患者需自行整理资料。这些发现可用于形成候选问题，尚不足以确认普遍需求或确定最终产品。

## 样本与证据范围

| 编号  | 受访者角色    | 主要经历                  |
|-----|----------|-----------------------|
| C01 | 父亲 家庭照护者 | 为妻子与女儿预约、陪诊和协调就医      |
| P01 | 母亲 患者兼家属 | 自身慢性病就医、女儿皮肤就诊及父亲就医回顾 |

素材来自 2026 年 10 月 2 日的家长口述及父亲随后补充，供 Joanna 复核并补充访谈信息。访谈时长、具体医院、事件日期、困难发生频率和时间成本尚未完整记录。

两位受访者的经历相关，不能当作两个相互独立的家庭样本。部分经历发生于过去，当前流程可能已变化；中国场景中的发现也不能直接推广至美国。能否计入主办方要求的访谈次数，应向现场确认。

## 团队使用方式

先由受访者核对各自记录，再选择待验证假设。队友可复制后附访谈提纲与记录模板，保留不同或相反的反饋，最后汇总独立家庭与专业人员的发现。

# 父亲访谈记录

编号 C01    角色 家庭照护者    主要环境 中国就医经历

## 承担的任务

受访者为妻子与女儿处理挂号、陪诊和就医协调。他的负担主要发生在获得医疗服务之前：需要辨别科室与门诊、查找放号规则，并在可用号源中寻找合适时间。

## 受访者描述的困难

| 发现编号  | 口述内容摘要                                    | 希望完成的任务                        |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| C01-1 | 不确定病因时，不知道挂哪一科；内科等类别还细分为多个专科。             | 在挂号前了解合适的服务入口，并知道何时需要人工导诊。     |
| C01-2 | 同一科室下有多个门诊或相近名称，不清楚彼此区别。                  | 看懂门诊服务范围、适用对象和预约条件。            |
| C01-3 | 线上预约需要提前抢号，但放号时间不容易找到。                    | 获得可靠的预约规则与提醒，减少反复查看。           |
| C01-4 | 身体不舒服时，可能只能约到较晚日期；曾感到只能自己熬过症状。            | 及时获得合适的服务选项和专业咨询入口。            |
| C01-5 | 希望预约高级职称的主任医师，但号源难约；不清楚目标医生在哪家医院坐诊、从哪里预约。 | 查清目标医生的官方坐诊地点、时间与预约入口，并了解可用号源。 |

## 需求解释与待核事实项

团队解释：受访者希望减少导航与协调成本，并提高获得服务的及时性。信息不清楚与号源不足是不同问题，需分开验证。AI 可能改善信息查找与提醒，但无法创造号源或保证预约成功。

待追问：最近一次挂号在哪个平台、卡在哪一步、花了多久？对目标医生，是已知姓名，还是只按职称选择？在哪里找过坐诊与预约信息？最终如何就诊？

## 候选 AI 机会

检索医院官方科室、门诊与医生出诊信息，展示来源、适用范围和预约入口；标明查询时间，经确认创建放号提醒。目标医生信息难找可由 AI 协助，号源不足不能靠 AI 消除；职称不作为适合具体病情的唯一依据。实时查询与预约取决于授权和系统接口，模拟连接须标明。

# 母亲访谈记录

编号 P01 角色 患者兼家庭成员 主要环境 中国就医经历

## 自身及家属经历

受访者有哮喘相关就医与用药经历，也参与女儿皮肤就诊和家属就医。她认为部分看诊解释不足，离开诊室后仍需自行查找信息；她欣赏 AI 可反复提问、解释较细致的沟通体验。

| 发现编号  | 口述内容摘要                            | 希望完成的任务                    |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| P01-1 | 部分就诊很快结束，拿到药后仍不清楚使用安排、疗程与原因。      | 理解已确认的医嘱，找到缺失信息的确认渠道。      |
| P01-2 | 女儿皮肤就诊时，感觉医生查看后很快开药，解释与追问机会有限。    | 了解后续护理与复诊安排，核对对自己是否理解。     |
| P01-3 | 某次处理皮肤问题时，现场排队和取牌体验混乱。            | 清楚知道排队步骤与下一步安排。            |
| P01-4 | 部分旧检查资料需要自己携带，跨次就诊的信息交接费力。        | 把既往记录整理成可核对、方便携带的资料包。      |
| P01-5 | 对治疗必要性有疑虑；家属曾得到不同的住院建议。           | 理解建议依据、替代方案及如何获取第二意见。      |
| P01-6 | 曾因 AI 解释详细而选择向 AI 咨询，包括未就诊时的健康疑问。 | 获得易懂解释和持续提问机会，同时知道何时需专业评估。 |

## 需求解释与待核实现事项

团队解释：核心需求是理解、参与和后续支持。沟通满意度不能作为医学准确性的证据；报告不据此认定 AI 比医生诊疗更可靠。看诊时间属于受访者回忆，未测量。

家属曾获不同住院建议，反映受访者的不确定与信任负担。缺少完整病历，不能裁定建议是否错误或存在过度医疗；后来关于医生被查办的口述，也不作为临床判断证据。

待追问：最近一次没听懂的是哪条书面或口头医嘱？当时如何追问？疑问由谁解决？哪些解释已包含在资料里？误解是否造成了具体后果？

# 候选问题与 AI 可行性分析

以下为团队分析与产品假设，并非受访者已验证的产品需求。应由后续访谈检查，再决定开发方向。

| 候选方向      | AI 可承担的动作                              | 主要限制                     |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------|
| 医嘱理解与执行   | 提取已确认安排；标记缺失项；生成专业确认清单；核对理解；经确认创建任务。   | 不补出疗程、不改药；需要可靠输入和专业确认渠道。 |
| 就诊资料整理    | 读取用户提供的文件；建立带出处的时间线；标记缺失与冲突；生成就诊资料包。   | 无法自动取得未授权记录；需核对提取准确性。    |
| 科室门诊与医生导航 | 检索官方科室、门诊和医生坐诊说明；展示预约入口；引导人工核实；创建放号提醒。 | 分科含临床风险；规则与号源依赖当地系统。     |
| 现场排队与预约   | 有授权数据时查询状态、提醒下一步。                      | 缺少医院接口时无法准确展示实时队列。       |
| 治疗建议澄清    | 整理不同建议及资料；形成向医生追问与第二意见准备清单。            | 不能判断医生动机或凭零散材料裁定治疗必要性。   |

## 建议优先验证的方向

优先访谈验证医嘱理解与执行，其次是就诊资料整理。前者与母亲的经历、团队的人机交互研究及短期演示条件相连；是否采用仍取决于现场需求和技术资源。

候选工作流：读取虚构就诊说明 → 提取安排并标出出处 → 发现缺失或冲突 → 形成专业确认事项 → 核对患者理解 → 经用户确认调用任务工具 → 显示执行状态。需要专业判断的事项在确认前暂停；模拟连接需明确标注。

## 下一轮验证与评估

向医生、护士或药师核实：患者常误解哪类安排、现有支持由谁提供、专业人员需要审核什么。再向不同家庭的患者或照护者核实具体经历，并检查现有工具是否已解决问题。

原型可测：任务提取是否准确、缺失信息是否被标出、未经确认是否会执行、用户能否准确复述下一步。不以三天原型声称改善临床效果。

# 队员家长访谈提纲

建议时长 15 至 20 分钟 参与方式 一人主问 一人记录

每次访谈一位受访者，先确定其患者或照护者角色；双重角色分别记录。

## 开始前

说明访谈用于学生医疗 AI 项目，询问是否同意记录及匿名向团队分享。可以跳过问题，不必提供姓名、医院账号或完整病历；录音、文件与照片另行征得同意。

## 核心问题

1. 您主要是自己就医，还是为家人预约、陪诊和照护？通常负责哪些事情？
2. 请讲一次最近或印象最清楚的就医经历。大约什么时候、在哪类机构、当时要完成什么？
3. 从开始到结束，具体做了哪些步骤？涉及哪些人、平台和资料？
4. 哪一步最麻烦？请讲发生了什么，而不只评价它好不好。
5. 您遇到过几次类似情况？每次大约耗费多久？不处理会有什么影响？不知道可以直接说。
6. 当时用了什么办法解决？医院已有的服务或工具哪些好用，哪些仍不够？
7. 就诊结束后，您清楚下一步要做什么吗？哪条安排不清楚？最后向谁确认？
8. 如果只能改善一个环节，您最希望改善哪个？为什么？
9. 针对刚才这个任务，您愿意让工具帮忙哪些步骤？哪些必须自己或专业人员确认？
10. 还有什么重要经历没谈到？我们可以向谁了解这项任务的另一面？

## 按角色追问

患者：您收到哪些说明？是否有机会提问？哪些信息仍需确认？

照护者：您如何替家人查信息、协调时间和交接资料？哪些步骤需要家人授权？

先完成问题访谈，再介绍产品想法。避免“您是不是也觉得很麻烦”“有 AI 肯定更方便吧”等引导问法。受访者没有困难、已有办法很好或不愿使用 AI，也应完整记录。

# 可复制的访谈记录模板

每位受访者复制一份。留空表示尚未获得信息，不补写数字或结论。

## 基本信息与同意

访谈编号 \_\_\_\_\_ 访谈人 \_\_\_\_\_ 记录人 \_\_\_\_\_

日期与时区 \_\_\_\_\_ 时长 \_\_\_\_\_

角色 患者 / 照护者 / 其他 \_\_\_\_\_

就医国家或地区 \_\_\_\_\_ 机构类型 \_\_\_\_\_

同意记录 \_\_\_\_\_ 同意匿名团队分享 \_\_\_\_\_ 录音另行同意 \_\_\_\_\_

## 真实经历与流程

具体事件与大致日期

\_\_\_\_\_

要完成的任务与流程步骤

\_\_\_\_\_

最困难的一步及原因

\_\_\_\_\_

发生频率 时间成本 影响及其依据

\_\_\_\_\_

现有办法及有效之处

\_\_\_\_\_

## 原话与团队解释

受访者原话 尽量逐字记录 非逐字记录请标明转述

\_\_\_\_\_

团队解释 与原话分开

\_\_\_\_\_

仍需追问或核实的事项

\_\_\_\_\_

产品假设与后续验证

可能的 AI 动作及必须由人确认的环节

---

这次访谈支持 修改或否定了什么假设

---

下一位相关受访者与验证问题

---

汇总规则：区分受访者人数与独立家庭数；不把方便抽取的家长样本写成代表性调查；美国场景另行验证。保留相反意见，使用匿名编号，不附可识别个人的病历。